心不全を契機に発見された左房内悪性腫瘍の一症例

◎進士 祐希[1)]、磯貝 美帆[1)]、小山 裕香[1)]、小泉 由喜奈[1)]、花井 甲太郎[1)]、宮地 千恵子[1)]
地方独立行政法人知多半島総合医療機構 知多半島総合医療センター[1)]

【はじめに】心臓腫瘍は塞栓症や心不全等を契機に発見されることも多く，心臓超音波検査の果たす役割は大きい．今回我々は，左房内腫瘍により僧帽弁狭窄様の急激な血行動態破綻をきたし，術後の病理組織学的検査にて極めて稀な悪性腫瘍と診断された症例を経験したため報告する．

【症例】40 歳代女性．既往歴：喘息，高血圧．息切れを主訴に近医を受診，両側肺浸潤影を認め当院紹介．肺炎疑いで外来経過観察中，徐々に症状が増悪し精査目的にて入院となった．血液検査で BNP 562.7pg/mL と上昇，胸部 X 線で心拡大を認めたため，心臓超音波検査を施行した．

【入院時心臓超音波検査】左房後壁に付着する最大径 53.8×32.1mm の可動性のある腫瘍性病変を認めた．拡張期に腫瘍が僧帽弁口に陥入しており，平均左房―左室間圧較差は 16.2mmHg で重度の僧帽弁狭窄が示唆された．また，推定右室収縮期圧 70.9mmHg と高値を示し，左室中隔の圧排を伴っていた． LVEF59.5%で左室収縮能は正常範囲であった．

【経過】腫瘍による急性心不全と診断され，第 7 病日に腫瘍摘出手術と三尖弁輪形成術を施行. 第 20 病日の心臓超音波検査では左房内異常構造物は認めず，左心房拡大や推定右室収縮期圧（20mmHg）の改善を認めた．術後病理組織学的検査の結果，極めて稀な悪性筋周皮腫（Malignant myopericytoma）と確定診断された．

【考察】左房内腫瘍の約 9 割は良性の粘液腫であり，卵円窩付近から発生することが典型的である．しかし本症例では，腫瘍は左房後壁側に認め，好発部位とは異なっていた．典型的な粘液種と異なる所見を認めた場合，悪性腫瘍の可能性を排除せず，入念な発生部位の観察や血行動態を迅速に臨床へ報告することが必要である．このような希少な悪性腫瘍において，迅速な病態把握と治療介入が救命において極めて重要であり，心臓超音波検査はその第一選択として不可欠な役割を担うと考えられた．

【結語】今回我々は，急性心不全の原因特定から緊急手術に至るまで，心臓超音波検査が有用であった左房内悪性筋周皮腫の一例を経験した．

連絡先：0569-89-0515（内線 2021）